聖路加国際病院　集中治療科（ICU）

災害対応マニュアル

火災・地震・電子カルテダウン。最初の数分の動き方。

2026年10月 改訂版

火災を見つけたら

3つを、同時に。

ひとりで順番にやらない。周りに声をかけ、手分けして一斉に動かす。

1

通報する

防災センター **4170**
消防 **119**

2

初期消火する

消火器、または
消火用散水栓で

3

避難誘導する

最初に**リーダー**を
決めてから

いちばん大切なのは、自分の身の安全。無理な消火はせず、危険を感じたらすぐに避難する。

目次

7つの章と、セルフチェック。

01 火災の初動
02 避難誘導と避難経路
03 火災設備
04 排煙システム
05 地震が起きたら
06 災害物品
07 カルテダウン
✓ セルフチェック

01　火災の初動

知らせる。消す。

連絡先、道具の場所、使い方。手が勝手に動くまで覚えておく。

連絡先は2か所。両方に知らせる。

防災センター	**4170** 消火用散水栓の扉の中の非常用電話、または固定電話・PHSから。
消防署	**119** 固定電話・PHSから**ゼロ発信**で。

119番でこう聞かれたら

「火事ですか？　救急ですか？」 → **「火事です。」**

「聖路加国際病院です。住所は東京都中央区明石町9-1。4階ICU、〇〇（氏名）です。」

ICU周辺の消火器と消火用散水栓

消火器（2か所）	1 ICU入り口　2 休憩室（医科部屋）前
消火用散水栓（3か所）	1 ICUカンファレンス室前　2 ICU⑩番前　3 OR更衣室出入り口前

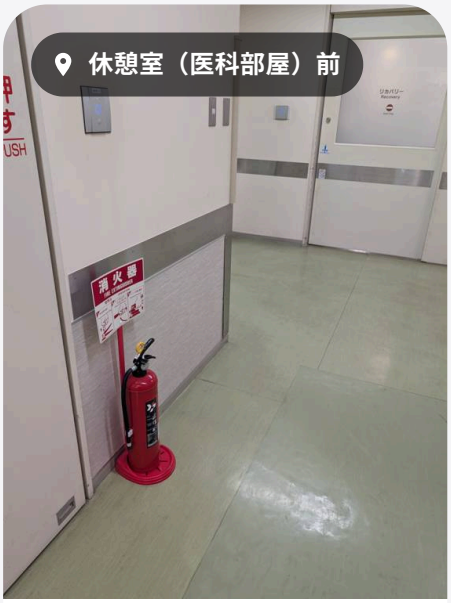
消火栓は院内に15メートルおきにある。一度、自分の足で歩いて場所を確かめておく。



消火器

ICU入り口

自動扉のすぐ横。



消火器

休憩室（医科部屋）前

リカバリーの扉の手前。



消火用散水栓

ICU⑩番前

上に**非常用電話**と赤いベル。

消火器の使い方

1. 安全ピンを抜く。
2. ホース（ノズル）を**火元**に向ける。
3. レバーを強く握って放射する。

炎の先端ではなく、燃えている「火元」をねらうと消えやすい。

消火用散水栓（屋内消火栓）の使い方



消火用散水栓

扉の中に**非常用電話**。ここから防災センター（4170）へ直接つながる。

1. **赤いベル**を鳴らして、周りに知らせる。
2. ホースを伸ばす。
3. **赤いレバー**を下げる。手元まで水が来る。
4. ホース手元の**緑のレバー**を下げる。放水が始まる。

注意

水圧が高い。金属部分をしっかり持つ。

02　避難誘導と避難経路

誰が先導し、
どこから外へ出るか。

避難は、リーダーを決めるところから始まる。

1. まず**リーダー（誘導係）**を決める。先頭と最後尾の確認役もはっきりさせる。
2. 防火扉は「**押して、引く**」。押すのとほぼ同時に引くと動く。

4階の避難階段は4か所。どれも直接、屋外へ。

1. オペ室内
2. CCM
3. 4E病棟の奥
4. 4W病棟の奥

スタバ前の防火扉と防火シャッター



スタバ前の防火扉

扉の下のハンドルを**回して引く**と動く。慌てると開けにくいので、一度体で覚えておく。



防火シャッター操作盤

赤丸の部分を押すと防火シャッターが降り、火と煙の広がりを止める。



遠くから見た位置

左に操作盤、奥がスタバ。



防災訓練から

防火扉の開け方を、実際に手を動かして確かめる。

03　知っておきたい火災設備

天井を、見上げる。

写真を見て、名前と働きを言えるように。



感知する

煙感知器

煙を感知すると**自動で火災を知らせる**。煙の出る処置では誤作動に注意。



消す

スプリンクラー

周囲が**70°C以上**になると感熱部が反応し、**自動で放水**する。手動操作は不要。



照らす

非常用電気（LED照明）

停電時に自動で点く。点灯は**約1時間**だけ。明るいうちに避難する。

04　排煙システム

いちばん危険なのは、煙。

見通しを奪い、有毒ガスで命にかかわる。排煙設備を見つけたら、迷わず作動させる。



排煙ボタン

見つけたら、**すべて押していく**。院内のあちこちにある「隠れミッキー」。普段から探して覚えておく。



排煙ハンドル

ボタンを押す → バーを引き出す → ハンドルを回す。窓が開き、煙を外へ逃がす。



スタバ前の排煙ボタンは3つ。　煙が出ていたら、3つとも全部押す。

05　地震が起きたら

逃げ道をふさがない。閉じ込められない。

揺れが収まったら、まず扉とエレベーター。

自動扉は、開けたまま固定する。

どうする	**養生テープで留め、開放したままの状態にする。**
なぜ	揺れや停電で扉が開かなくなると、避難経路がふさがり、閉じ込められるおそれがある。
テープの場所	災害物品（ICU5番前の棚）に入っている。

エレベーターには乗らない。

乗っていたら

最寄りの階で、必ず降りる。閉じ込められると、復旧に**4〜5時間**かかることがある。

06　災害物品

どこにあり、
何が入っているか。

一度棚を開けて、中身を自分の目で確かめておく。

置き場所

ICU 5番前の棚の中



扉を閉めた状態

「5」の番号と「災害関連」のシールが目印

右側の扉の上に「災害関連」と貼ってある。



扉を開けた状態

2段に分けて入っている

上段：ランタン、ファイル類など。**下段**：災害トイレ、軍手、養生テープ・ガムテープ、ラジオ付きライトなど。

記録と指示

- 手書き用指示書
  DOCTOR'S ORDER SHEET
- 手書き伝票
- 3色ボールペン

明かりと情報

- 懐中電灯
- ランタン
- ラジオ

生活と作業

- 災害トイレ
- 軍手
- 養生テープ・ガムテープ

ほかにも入っている。

07　情報共有と電子カルテダウン

情報は1か所に。
カルテが止まっても、
指示と輸血は止めない。

紙に切り替える手順を、先に決めておく。

院内放送の内容を書く場所

情報共有

中央のホワイトボードの上に「災害用シート」を貼り、そこに書く。

近くのホワイトボードに直接書くのではない。全員が同じ1か所を見る。

電子カルテが使えないとき

参照カルテ	**全部のPCでは使えない。** ホーム画面に「参照カルテ」のアイコンがあるPCだけで使える。どのPCか、普段から確かめておく。
医師の追加指示	**救命救急センター ICU DOCTOR'S ORDER SHEET**（Dr's order sheet）に手書きで書く。 用紙は災害物品の中にある。
輸血の認証	**輸血用血液支給票**と**血液（製剤）**を照らし合わせて、ダブルチェックする。
ダブルチェックの相手	**医師と看護師**で行う。

セルフチェック

答えを隠して、言えるか。

災害クイズ18問。カードを押すと答えが出る。言えなかったら、右上の章に戻る。

災害クイズ①　基本情報編

1　**ICU周辺の消火器の位置（2か所）**　01

ICU入り口／休憩室（医科部屋）前

2　**消火器の使い方の順番**　01

安全ピンを抜く → ホース（ノズル）を火元に向ける → レバーを強く握り放射する

3　**ICU周辺の消火用散水栓の位置**　01

ICUカンファレンス室前／ICU⑩番前／OR更衣室出入り口前

4　**消火用散水栓の使い方の順番**　01

赤いベルを鳴らす → ホースを伸ばす → 赤いレバーを下げる → 緑のレバーを下げる

5 火災発生時の連絡先（複数） 01

防災センター（4170）と消防署（119）

6 ICUの災害物品の場所 06

ICU5番前の棚の中

7 災害物品の中身 06

手書き用指示書、手書き伝票、災害トイレ、ラジオ、ランタン、懐中電灯、軍手、養生・ガムテープ など

8 地震発生時の自動扉 05

養生テープで留め、開放したままの状態にする

9 写真：天井の丸い装置 03

煙感知器

10 写真：天井の散水装置 03

スプリンクラー

11 写真：天井のLED照明 03

非常用電気（LED照明）

12 4階の非常階段（4か所） 02

オペ室内／CCM／4E病棟の奥／4W病棟の奥

災害クイズ② 応用編

1 院内放送の内容はどこに記載する？ 07

中央のホワイトボードの上に災害用シートを貼り、そこに記載する

2 参照カルテは全部のPCで使える？ 07

使えない。ホーム画面に「参照カルテ」アイコンがあるPCのみ

3 災害時にエレベーターに乗っていたら？ 05

最寄りの階で必ず降りる

4 ダウン時の輸血の認証とダブルチェック 07

輸血用血液支給票と血液を照らし合わせてダブルチェック

5 そのダブルチェックは誰と？ 07

医師と看護師で行う

6 カルテダウン時、医師の追加指示はどこに？ 07

救命救急センターICU DOCTOR'S ORDER SHEET（Dr's order sheet）に記載

備えあれば、憂いなし。

日頃の確認が、いざという時の落ち着いた行動につながる。

改訂履歴

初版 2024年6月28日 ／ 追記 2025年7月11日 ／ 追記 2026年6月14日

改訂 2026年10月10日 災害クイズの内容を反映（消火器・消火用散水栓の場所、地震時の自動扉、災害物品、情報共有と電子カルテダウン時の運用、セルフチェックを追加）

PDF：早見表（A4横1枚・ラミネート用） ／ マニュアル全体（A4）

作成：聖路加国際病院 集中治療科